★★★ 感染（0~3 题）

概述

- 特异性感染：破伤风、结核、真菌如念珠菌、气性坏疽“凤姐真坏”
- 外科用抗生素原则（2025）
  - ①不是所有外科感染都要用
  - ②用药也不能减免外科处理：去除感染灶 + 通畅引流是外科治疗基本原则
  - ③有明确指征才预防性用药
  - ④联合用药要有明确指征：严重、混合、需长时间用药病原菌易耐药的感染、减少个别药物剂量以降低毒性反应

	主要致病菌	主要表现	外科处理
蜂窝织炎（2014）	乙型溶血性链球菌	脓液稀薄、边界不清	
丹毒 （皮肤淋巴管网） （2008、2019、2020）	乙型溶血性链球菌	下肢（足藓）、面部（口腔溃疡 / 鼻窦炎）等 边界清楚的片状红疹（周围鲜红 + 中间淡红“一片丹清红淡红”） 反复发作可致象皮肿（淋巴管阻塞）	①不切开引流（很少有组织坏死化脓） ②症状消失后继续用药（治愈后易复发）
疖	金葡菌	1 个脓点	
痈	金葡菌	糖尿病等，多个相邻脓点，项背部多见“搭背”	①十字切口、超过边缘、深达筋膜、填塞脓腔 ②发生在危险三角如唇痈：严禁挤压和切开 （否则可致海绵状静脉窦炎 - 意识障碍）
甲沟炎	金葡菌	指甲两侧可呈 U 状	甲沟旁纵行切口
脓性指头炎 （2014）	金葡菌	鱼刺、甲沟炎蔓延等 指头针刺样疼痛→剧烈跳痛、肿胀加重→疼痛减轻	①末节指侧面纵行切口 ②切口近端不及指节横纹、远端不及甲沟 1/2 ③对口引流，指神经麻醉（不加肾）
掌深间隙感染	金葡菌	①掌中间隙：掌心凹消失（掌心隆起）、3/4/5 指受限 ②鱼际间隙：鱼际肿胀、1/2 指受限（不能对掌“算命”）	①切口近端不及掌横纹避免损伤掌浅弓 ②严禁切开肿胀的手背
化脓性腱鞘炎	金葡菌	1 指→桡侧滑囊炎，5 指→尺侧滑囊炎 2 指→鱼际间隙感染，3/4 指→掌中间隙感染	术后抬高患手 固定在功能位
化脓性滑囊炎	金葡菌		切口近端距腕横纹至少 1.5cm 避免损伤正中神经
脓毒症（2012、2018）	G- 杆菌	局部感染灶 + 突发高热或低体温 + 全身不适 +WBC 明显↑或↓ 血培养多次阴性考虑厌氧菌（臭）、真菌（结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑）	1h 内静脉用抗生素 + 处理原发感染灶 （休克者同时补充血容量）